Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Diego Alonso González Aranguiz				Sexo	F		M	X
Fecha Nacimiento	17/04/2013	Edad actual	12 años	meses	País natal:	Chile.			
Domicilio actual:	Calle casuto #402, Rinconada			Teléfono	944124503				
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒						
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒						
Escolaridad actual:	7mo A	Establecimiento	Liceo mixto los Andes.						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 01/04/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Natalia Aranguiz Adasme	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 01/04/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: María Constanza Oyarzún	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso al programa por diagnóstico TEA.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí **(especificar)**	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: TEA	Otro: Asma

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☒ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☒ NO | Peso: 3,350 | Talla: 51 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

38 semanas, de término.
Sin antecedentes relevantes durante el embarazo.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	~~Sí~~	No			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: Hospitalización bilirrubina alta. Neumonia.					
Se realizaron controles periódicos de salud		~~Sí~~	No		Vacunas		~~Sí~~	No

Observaciones:

Hasta los 4 años tuvo problemas respiratorios a los 3 años diagnosticado Asma.
Alergico y asmatico.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza:	Se sienta sólo/a: 6 meses.	Camina sin apoyo: 1 año.
Primeras palabras: 1 año, 1 a 2 mes	Primeras frases: 2 años	Se viste solo/a:

Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

Se cumplio con todos los hitos del desarrollo a la edad esperada. Se sento y luego camino. No gateo.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☒ normal ☒ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	~~No~~

Observaciones:
Poca movilidad (Rigidez de movimientos).
Intolerante al dolor.
Específico y claro para comprender prohibiciones.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	~~Sí~~	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Sí~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	~~Sí~~	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	~~No~~	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Sí~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	~~Sí~~	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	~~Sí~~	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~

Observaciones:
Le sangra la nariz con frecuencia y le duele la cabeza.
Sin evaluación oftalmológica.
La pronunciación oral no está adecuada porque no abre bien la boca para hablar.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma
☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	~~Sí~~	No	Emite/produce frases	~~Sí~~	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	~~Sí~~	No	Relata experiencias	~~Sí~~	No
Emite palabras/produce señas	~~Sí~~	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones simples	~~Sí~~	No
Identifica personas	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	~~Sí~~	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	~~Sí~~	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	~~Sí~~	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:
Le complica comprender conceptos abstractos.
Las instrucciones complejas que sean bien explicadas.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	~~Sí~~	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	~~No~~

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Explica razones de sus comportamientos y actitudes	~~Sí~~	No	Respeta normas sociales	~~Sí~~	No
Participa en actividades grupales	~~Sí~~	No	Respeta normas escolares	~~Sí~~	No
Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	~~Sí~~	No	Pataletas frecuentes	~~Sí~~	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☒ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
Siempre mantiene rutina, si algo cambia se descompensa.
Cuestiona decisiones.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	~~Sí~~	No
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Motor riguidez para agilidad de movimientos.
Asma, con tratamiento.

Alimentación: ☒ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad sobrepeso.

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 10 horas.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☒ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☒ serio ☒ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
Rebelde en el sentido de cuestionar todo.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Natalia Aranguiz	Madre	36	Univer.	Abogada.
2. Yoacim Santander	Padrastro	46	Tecn. incom.	Chofer camiones.
3. Agustina Santander	Hermana	6		
4. Lucas Santander	Hermano	4		
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):
Madre con Asma. Abuela materna con fibromialgia. Hermanos Asmaticos y alergicos.
Observaciones:
Sin observaciones.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar											
Edad de ingreso al sistema escolar	2 año			Asistió a jardín infantil			Sí ✓	No			
Nº de colegios en que ha estudiado	4			Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:							
Motivo de los cambios: Discriminación Combridge / cumplio ciclo Eliodio / Bulling Alcazar											
Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:							
Situación actual											
Nivel/curso actual	7 mo		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No ✓	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí ✓	No
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

A los 4 años empezó con selectividad alimentaria.

A los 4 años hubo un corte en el desarrollo.

8-9 años diagnosticado con TEA.

Medicación:
- TEA: Aripiprazol 15mg 1 en la mañana.
- TEA: Sertralina 75mg en la mañana
- TEA: Melatonina 1 pastilla en la noche.

} permanente

Asma → Brexotide 1 en la mañana 1 en la noche

- Debido a experiencias pasadas se encuentra reacio a venir al colegio.

- Padre biologico no tiene contacto con el estudiante. La custodia total la tiene la madre.

- Cuando el padre biologico aparece desordena la rutina y descompensa al niño (aparece 1 vez al año).